随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

外科学 腹部和肠道疾病

核心精讲·急性阑尾炎

（性感认识：转移性右下腹痛）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、可能可能最可能

1.常见病因：青年人淋巴滤泡明显增生等→阑尾阻塞+细菌感染

阑尾是免疫器官,有丰富淋巴组织,在20-30岁左右达到巅峰后逐渐退化,若退化后还发生阑尾炎,大概率是粪便或者肿瘤原因导致的

2.临床表现

①**突发转移性右下腹痛**（内脏神经定位不准确）：先上腹痛、逐渐移向脐部、约 6-8 小时后转移并局限于 **McBurney 点**（脐与右髂前上棘连线的中外 1/3 交界处）

炎症波及壁层腹膜(躯体神经支配,定位准确)

注意：转移性右下腹痛还可见于消化性溃疡急性穿孔：突发上腹刀割样剧痛、疼痛可迅速转移至右下腹、肝浊音界缩小消失，X 线膈下新月形游离气体

①原发部位不同:消化性溃疡穿孔最痛的部位在上腹 ②转移时间不同:穿孔出来的内容物迅速顺着右结肠旁沟流下来

②**右下腹固定压痛**：诊断急性阑尾炎最早、最常见、最有价值的体征

③发热、血 WBC↑

大部分外科疾病:先有局部症状→再有全身症状(吸收入血)
特殊:急性阑尾炎、急性胆囊炎 早期腹痛+发热(吸收入血后更严重)

④**并发化脓性门静脉炎、细菌性肝脓肿**：肝大、剑突下压痛、可有黄疸，B 超→穿刺

置管引流:不算手术
VS 切开引流:算手术

顺着肠系膜上V到达门V

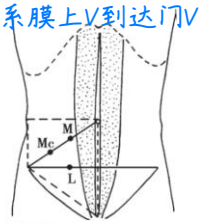
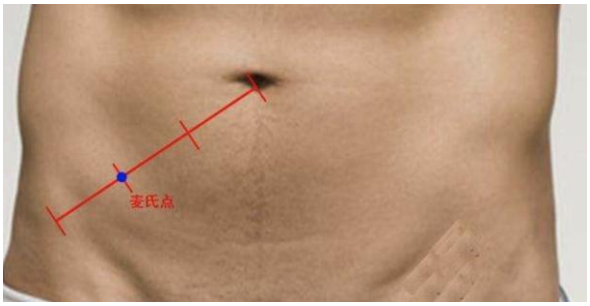


图 40-3 阑尾炎压痛点
M,Morris点;Mc,McBurney点;L,Lenz点;点线围成的四边形为 Rapp 压痛区。



3.试验（pro）

①结肠充气试验 Rovsing 征 sing：提示阑尾炎，但阴性也不能排除诊断 将结肠内的气体赶向盲肠、阑尾,引起阑尾疼痛

②**腰大肌试验 Psoas 征**（患者左侧卧位）：提示阑尾位置深（**盲肠后位/腹膜后位**）PS 做神猴。盲肠后位/腹膜后位的阑尾炎可有右侧腰背部痛 腹膜刺激征可不明显

③**闭孔内肌试验 Obturator 征**（患者仰卧位）：提示阑尾位置低（**盆位**）闭 b-仰-低。盆位的阑尾炎其腹痛在耻骨上区、直肠指检直肠前方有触痛 可有里急后重

